

Fecha Última Actualización: 18-07-2024 2:39:31

Página 1 de 6

Información Paciente

Nombre : Paola Del Carmen Galaz Marin	Rut : 11.850.530-1	N° Archivo : 2416594	N° Epicrisis : 406677
Edad : 53a 0m 5d	Fecha Nacto : 13/07/1971	Sexo : Femenino	
Dirección : Valle De Los Reyes 1811 412 Dpto. 412	Comuna : Maipu	Teléfono : 9 9001 0626	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim	Fecha Ingreso : 10/07/2024 21:20	Días Estadía : 8
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso : 18/07/2024 02:07	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Traslado hospital El Carmen

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Ingreso UPC A1 17/07
Paola Galaz Marín, 53 años, 11850530-1

FI HEC: 26/06
FI CASR: 10/07
FI UTIM: 10/07
FI UPC: 17/07

Antecedentes

- 1) Médicos: DHC de etiología no clara, colelitiasis asintomática
- 2) Quirúrgicos:
- 3) Medicamentos: Ciprofloxacino 500 mg QD, Lactulosa 20 mL TID, Ácido Ursodeoxicólico 500 mg BID
- 4) Alergias: Niega.
- 5) Hábitos: (-).
- 6) Hospitalizaciones: 09/06/24 al 14/06/24 por ascitis a tensión asociada a trombocitopenia moderada y encefalopatía hepática.

Anamnesis

Paciente con antecedentes descritos. Consulta el 26/06 en SU HEC por cuadro de 1 día de evolución de CEG, malestar general, náuseas y episodio de desorientación. Niega fiebre, diarrea, vómitos y otros síntomas. Ingresa en RCG afebril 36.1, bradicardia, hipotensa, saturando 98% con FiO2 ambiental. Al EF CLOTE con EH G2. Dentro de exámenes destacaba Hb 9.3, Hto 26.0, GB 4.300, PLQ 51.000, PCR 7.5, PCT 0.11, BUN 36.2, Crea 2.0, ELP 118/5.6/94, BT 10.7, BD 7.8, Alb 2.0, FA 206. GOT 38.8, GGT 10, INR 4.29. RxTx -> Sin evidencia de infiltrados ni condensación, se decide hospitalizar en UTI HEC para estudio y manejo.

Se inicia manejo con albúmina, terlipresina 1 mg TID EV + NAD a 0.05 mcg/Kg/min. Posteriormente se suspende terlipresina por hiponatremia severa. El 26/06 se instala CVC YD y se inicia NAD por acceso central. Evoluciona con requerimientos de NAD hasta 0.4 mcg/Kg/min, razón por la cual se traslada a UCI el 27/06. Por sistemas:

- En lo hemodinámico requiriendo NAD por 48 horas, titulándose a la baja con buena respuesta. Con requerimientos Tx intermitentes sin quedar clara indicación, en total se Tx 2 U de GR + 5 U de PLQ + 6 U de PFC + 8 U de Crio
- De lo ventilatorio con requerimientos de O2 intermitentes en contexto de congestión +/- neumonía, que se manejan con ATB y terapia depleitiva.

Fecha Epicrisis : 18/07/2024 02:39

Página 1 de 6

Fecha Última Actualización: 18-07-2024 2:39:31

Página 2 de 6

- En lo infeccioso con peak febril 30/06 por lo que se cultiva y se inicia Imipenem/Vancomicina/Amikacina. Se descarta PBE con paracentesis, completa 5 días de ATB, sin conflicto posterior.

- De lo hepatológico, cirrosis conocida sin etiología conocida. Sin conflicto ni terapias descritas por EH. Con 2 punciones de LA, sin criterios de PBE, se deja con terapia diurética. Evoluciona con falla renal que resuelve posterior a apoyo con NAD + Albúmina + Terlipresina. Se rescata EDA 10/06/24: Gastropatía hipertensiva portal de cuerpo leve, Gastropatía crónica de aspecto atrófico de cuerpo y antro, Gastropatía petequeal de antro y fondo leve, Gastropatía eritematosa antral leve, Bulboduodenitis erosiva moderada, sin HDA durante estadía. Al parecer con antecedentes de tumor pancreático, se intenta realizar RMN en HEC pero paciente no tolera posición.

En contexto de ACLF con MELD Na 40 y ACLF 50 se traslada a UTIM CASR para estudio y manejo pre THO. Se describe a su ingreso CLOTE, bien hidratada y perfundida, con ascitis G2-G3, EEII con edema moderado bilateral y con CVC YD sano. Exámenes de ingreso destaca Hb 6.8, GB 4.580, RAN 4.000, PLQ 39.000, Láctico 1.8, PCR 32.3, BUN 13.4, Crea 0.56, ELP 135/3.0/96, BT 31.0, BD 20.85, Fibrinógeno <50, INR >10, TTPK >180.

Evolución en UTIM

- Hemodinamia: Tendiente a la hipotensión desde su ingreso, inicialmente sin elevación de lactato ni compromiso perfusional cínico. Hb ~7.0 asintomática durante los primeros días. Evoluciona con deterioro progresivo de macrohemodinamia el 16/07, iniciando NAD hasta 0.25 mcg/Kg/min y con aumento de láctico 1.7 -> 4.9

- Ventilatorio: Cursa con insuficiencia respiratoria aguda con requerimientos de O2 hasta 4 L/min en su ingreso, interpretada en relación a neumonía tratada, decúbito prolongado, congestión y ascitis. Con mayor apremio respiratorio desde el 16/07 AM, se decide IOT + conexión a VMI en vista de deterioro global de la paciente. RxTx post IOT con múltiples focos de condensación.

- Infeccioso: Se mantuvo con Ciprofloxacino como profilaxis de PBE. Se realiza paracentesis diagnóstica que descarta PBE el 14/07. Posterior a deterioro ventilatorio y hemodinámico se pancultiva e inicia Imipenem + Vancomicina por gravedad.

- Gastrointestinal: DHC con ACLF trasladada desde HEC para THO. DHC conocido, sin estudio etiológico en informe de traslado. Por complicaciones:

. EH: WH 2-3. con lactulosa para deposiciones en meta.

. Ascitis/PBE: Se mantuvo manejo con diuréticos con mala respuesta, además de progresar con AKI por lo que se suspenden el 16/07. Se realizan 2 punciones (1 diagnóstica y otra evacuadora 600 mL) el 14/07 y otra punción evacuadora de 600 mL el 15/07, destacando líquido hemorrágico con abundantes hematíes y caída de Hb 7.4 -> 6.2 en 24 horas.

. SHR: Evolucionó con AKI KDIGO II en HEC que respondió de manera adecuada a vasopresores. Evoluciona con aumento de creatinina desde su ingreso 0.56 -> 1.36, sin BH registrado (sin CUP) por lo que se solicita instalación.

. VE: Sin HDA durante estadía, sin evidencia de sangrado digestivo actual, deposiciones líquidas no melénicas.

. HCC: Al parecer hay antecedentes de tumor pancreático, pendiente definir con hepatología rol de este antecedente en miras de Trasplante. Se intentó realizar RNM en HEC pero paciente no tolera posición.

. Coagulopatía: Marcada, carga con vitamina K desde el HEC. Se Tx crioprecipitado y 100 ml de octaplex el 11/07. El 16/07 con sangrado por sitio de paracentesis y sitio de inserción de CVC. Se Tx 1 U de GR con Hb 6.2 -> 7.5 -> 7.3, en planes de Tx de PFC + Crioprecipitados.

. THO: Destaca dentro de estudio realizado pretrasplante con IgM en límite superior indeterminado e IgG (+) para VEB. A discutir con hepatología. Resto de estudio etiológico y de infecciones (-).

- ETE: Sin heparinas por coagulopatía severa.

Con deterioro hemodinámico, ventilatorio y renal en las últimas 48 horas, asociado a sangrado por sitio de paracentesis y sitio de inserción de CVC. En contexto de compromiso hemodinámico se decide IOT + conexión a VMI. SRI con Etomidato 20 mg + Rocuronio 100 mg, se realiza IOT al primer intento de primer operado, TOT #8.0, se deja a 22 cm de AD. Post IOT con NAD hasta 0.25, sedoanalgesia con Midazolam/Fentanilo, bien acoplada a ventilador. Exámenes -> Hb 7.2 (7.5) Hto 20.4 GB 9.920 (8.830) RAN 9.000 RAL 500 PLQ 84.000 ELP 129/4.7/92, GSA: pH 7.35, pCO2 33.0, pO2 178.3, HCO3 18.1, BE -7.4, PAFI 237, DCO2 10.6, SvO2 89.6, Láctico 7.9 (4.9). Se traslada a UPC para continuar manejo y estudio.

Ingresa grave, hipotensa con PAM ~44 y PAD ~30 con BIC de NAD a 0.25 que aumenta rápidamente a 0.6 logrando PAM ~60. En SAS 1 con BIC de Fentanilo/Midazolam, acoplada a VMI en AC/VC con TV 320, FR 26, PEEP 10, DP 10 con FiO2 50%. Se realiza ecoscopía, corazón hiperdinámico, sin parámetros de respuesta a fluidos, se inicia BIC de Vasopresina a 0.04 UI/min logrando descenso de NAD hasta 0.4. Se continua con Tx de PFC.

Examen físico al ingreso de la unidad.

SV (01:10): T 36.5, FC 113, FR 29, PA 94/39 (59), SAT 93% con FiO2 50% x VMI.

Fecha Epicrisis : 18/07/2024 02:39

Página 2 de 6

Fecha Última Actualización: 18-07-2024 2:39:31

Página 3 de 6

- En SAS 1 con sedoanalgesia mediante Fentanilo/Midazolam. Miosis hiporreactiva, corneal +/-.
- CRT < 2 segundos, algo fría a distal, mottling score 0 puntos. Impresiona bien perfundida y con VEC expandido. Yugulares ingurgitadas a 30°. Con apósito sobre sitio de inserción de CVC.
- RR2TNAS. MP (+), crépitos finos bilaterales.
- Abdomen globuloso con ascitis G2. Blando, depresible e impresiona indoloro a la palpación. Con apósito sanguinolento sobre FID.
- EEII sin edema ni otros signos de TVP.
- Ecoscopia -> VCI pletórica sin cambios durante respiración, VD < VI, FSG conservada, impresiona hiperdinámico, VTI 26-27, TAPSE 23.

Laboratorio

16/07 (PM): Hb 7.2 (7.5) Hto 20.4 GB 9.920 (8.830) RAN 9.000 RAL 500 PLQ 84.000 ELP 129/4.7/92, GSA: pH 7.35, pCO2 33.0, pO2 178.3, HCO3 18.1, BE -7.4, PAFI 440, DCO2 10.6, SvO2 89.6, Láctico 7.9 (4.9)

Destacables

14/07: Citoquímico LA -> Hemorrágico, amarillo, PT 14.0, Glu 117, GB 280, PMN 62%, MN 38%, Hematíes abundantes, Cultivo LA (P)

12/07: VIH NR, HTLV I/II NR, IgM/IgG Toxoplasma (-), IgG HSV1 (+), IgG HSV2 (-), IgG HVZ (+), IgM VEB ind, IgG VEB (+), PCR HHV-1/2/3 (-), aFP <2.0, T3 <30.0, IgM/IgG CMV (P), ANA (P), AMA (P), ASMA (P), IgG 1151, IgA 266, IgM 154

11/07: Portación (+) E. faecium vanB, Portación carbapenemasas (-)

Diagnósticos de ingreso

1) Cirrosis descompensada de etiología incierta

a. ACLF CLIF 61 puntos y Meld Na 45 puntos

- EH G1-2

- Ascitis G2-3 sin respuesta a diuréticos

2) FOM

- Disfunción circulatoria

- Insuficiencia respiratoria aguda

- AKI KDIGO II-III

- Coagulopatía (INR >10, TTPK >180)

- Hiperbilirrubinemia (>30)

3) Obs. NIH multilobar vs Congestión?

4) Bicitopenia

a. Anemia severa

b. Trombocitopenia moderada

5) NIH de LM + LID tratada

6) Antecedentes.

Planes

-HDN: Con requerimientos de NAD al alza desde su ingreso, por perfil ecográfico se decide inicio de VSP con buena respuesta. Sin parámetros de respuesta a volumen, suspendo albúmina a horario

-Vent: Cursando insuficiencia respiratoria con rápido deterioro durante las últimas 24 horas. Destaca RxTx con múltiples condensaciones, se solicita TAC para mejor caracterización. Mantener en SAS 1 con parámetros protectores

-Hemato: Evolucionando con coagulopatía importante, con Tx de 2 U de GR + 6 U de PFC + 6 U de Crio en curso. A descartar sangrado abdominal posterior a paracentesis previas

-Infec: Se pancultiva a su ingreso y se deja cobertura con Imipenem + Vancomicina de manera empírica.

-Gastro: ACLF con reagudización que impresiona en contexto séptico vs hemorrágico.

-Nefro: Solicito serologías por eventual necesidad de TRR en el corto plazo

-Nutri: Dejo en régimen cero, instalar SNG una vez con Tx ya pasada.

-Neuro: SAS 1 con Fenta/Mida

-Profilaxis: iBP

- NAD + VSP para PAM >65 mmHg

Fecha Epicrisis : 18/07/2024 02:39

Página 3 de 6

Fecha Última Actualización: 18-07-2024 2:39:31

Página 4 de 6

- VMI con parámetros protectores
- Imipenem/Vancomicina posterior a cultivos
- Completar Tx de hemoderivados
- Solicito TAC de Cerebro + TAC de Tórax + AngioTAC AP

17/07/2024 10:35:05

S.De La Maza

Muy grave.

Falla hemodinamica (shock refractario), falla ventilatoria SDR grave, insuficiencia hepática severa, falla renal anúrica.

Se trasladó a UCI ante sospecha de shock hemorrágico pero AngioTAC descarta sangrado activo. Se transfundió 4 UGR, 6U PFC y 6 crioprecipitado. Sin lograr corrección de estado hemodinámico.

Actualmente:

1. HDN: Hb 6.4 (intra transfusión), NAD 0,55 ug/kg/min, Vasopresina 0.04 UI/min, láctico 50. Solo con sangrado de mucosas evidente.

2. Ventilatorio: SDR grave secundario a congestión pulmonar y obs neumonia bi basal. PAFI 120, Ventilada modo VC Vt 290-->320, DP 14, Meseta 24, Cest 22, Peep 10. Acidosis respiratoria con pH 7.25, pCo2 50, Vminuto 9.3.

3. Infectológico: Sin evidencia de infección previa, PCR estacionaria en 30 pero con shock refractario en evolución. TAC muestra focos de condensación extensos bi basales. Cubierta empíricamente con Vancomicina e Imipenem, cambio a Linezolid por antecedente de portación ERV Van B. Pancultivada con resultados pendientes, se evaluará cambio CVC de larga data. Paracentesis reciente sin criterios de PBE.

4. Renal: Aki en evolución, oligoanúrica, sin criterios de urgencia dialítica por números. Se definirá modalidad de TRR con equipo de nefrología.

5. Régimen cero por DVA en dosis altas, vigilar glicemias.

6. Profilaxis con heparina contraindicada por sangrado, mantiene IBP.

Pupilas mióticas isocóricas.

Sedada SAS 1. Escleras ictericas ++, hemorragia subconjuntival.

Yugos visibles (+)

CRT < 2 seg

VEC expandido ++

Sangrado en sitios de punción

Cardio 2T soplo sistólico foco tricuspideo.

Pulmonar con crepitaciones bibasales

Abdomen: distendido, ascitis ++, compresión activa sobre sitio de punción de paracentesis. Depresible.

EEII con edema leve bilateral, sin signos de TVP.

- Control seriado perfusión

. Inicio corticoides dado shock refractario

- Solicito EDA

- Por ahora mala candidata a LBA dados altos requerimientos de Fio2.

- Mantengo cobertura antibiótica hoy dosis full

- Se definirá con nefrología modalidad de TRR.

17/07/2024 11:33:41

A.Briones

Nefrología

Paciente cursando shock séptico de foco pulmonar.

Noradrenalina 0.5, vasopresina 0.04.

Anúrica, BH +1600.

Exámenes de hoy: Na 125 K 4.64 Crea 2 Bun 28 Calcio 9,2 pH 7.25 HCO3 21.

Plan:

- Hoy HVHF:

AV1000

Qt 24:00

Qb 200

Qs 4200 post filtro por 8 horas, luego bajar a 2000 ml/Hr

Fecha Epicrisis : 18/07/2024 02:39

Página 4 de 6



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 18-07-2024 2:39:31

Página 5 de 6

MultiBic 4K, llevar Na a 130
AC (-)
BH neutro

- Control de Na c/6 hrs, para evitar sobre corrección.

Briones, becado medicina interna / Julio, nefrólogo.

17/07/2024 18:47:51
P.Bec Álvarez
CIRUGIA HPB

Paciente conocida, en espera de Transplante hepático. Ayer evoluciona con compromiso del estado general, falla renal, epistaxis y sangrado de sitio de punción de paracentesis evacuadora, con falla respiratoria, por lo cual se intubó y traslado a UCI, además de requerimientos al alza de DVA.

Hoy HDN inestable, con NAD 0,8 + Vasopresina, en TRR.

Ex físico: sin variaciones en relación a días previos.

Plan:
-Manejo por UCI
-Por ahora no candidata a transplante por condición de gravedad

17/07/2024 22:59:25
S.De La Maza

Durante el día se instala CVC HD para HFAV femoral derecho sin incidentes y se intenta instalación de CVC YI (por cambio dado CVC YD de 22 días de antigüedad asociado a shock séptico refractario) que pese a punción fácil resulta frustra tras tope de guía en dos oportunidades. Desarrolla pequeño hematoma periyugular que se controla con medidas compresivas habituales, sin punción arterial evidente. Se desiste de instalación dado CVC funcional y coagulopatía. Se mantiene sin cambios dentro de su extrema gravedad, en shock séptico refractario secundario a neumonia, se conecta a HFAV con NAD 0.8 ug/kg/min, vasopresina a 0,04 ug/kg/min y se inicia adrenalina a 0.5 ug/kg/min. En paralelo se obtienen exámenes que muestran láctico 35 (50), Hb 7.6 (6.4) pero INR en 7.0 (previo 2.7). Se indica nuevamente transfusión de 6 U PFC. Tras aproximadamente dos horas de conexión evoluciona con requerimiento de DVA al alza y aumento de volumen cervical en sitio de punción, hematoma de rápida expansión, con compromiso facial y pectoral. Se transfunden 2UGR mientras completa plasma, además de volemisación generosa con albúmina , sin respuesta hemodinámica. Se da aviso a familiares de pronóstico ominoso y situación actual irreversible. Paciente no candidata a estudio con Angiotac o medidas quirúrgicas, no trasladable. Al momento de esta evaluación familiares acompañan a paciente, se explica reiteradamente pronóstico a corto plazo.

Larenas/De la Maza

18/07/2024 02:30:22
S.De La Maza

Se constata fallecimiento a las 02:07 AM en presencia de familiares. Realizo certificado de defunción y emito epicrisis.

Diagnóstico de Egreso

INSUFICIENCIA HEPATICA CRONICA - ACLF, falla orgánica múltiple, shock séptico.

Condición de Egreso

Fallecida

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Fallecida

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 18/07/2024 02:39

Página 5 de 6

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:06

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 18-07-2024 2:39:31

Página 6 de 6

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Simon De La Maza Fontecilla

Médico Tratante (Staff)